

Zusammenfassung der Prüfungssimulation

Diese Prüfungssimulation fand am 14. Mai 2026 statt. Der Kandidat bereitet sich auf seine Fachsprachenprüfung (FSP) für Innere Medizin in Düsseldorf vor. Die Simulation dauerte etwa 20 Minuten und umfasste sowohl ein Arzt-Patienten-Gespräch als auch eine Fallvorstellung im Arzt-Arzt-Gespräch.

Fallbeschreibung

Der simulierte Patient, Oskar Schmidt (50 Jahre alt, Schreiner), stellte sich mit klassischen Symptomen einer gastroösophagealen Refluxerkrankung (GERD) vor: brennende retrosternale Schmerzen, Sodbrennen, Dysphagie, nächtlicher Husten und Heiserkeit. Besonders besorgniserregend war die positive Familienanamnese mit einem Bruder, der an Speiseröhrenkrebs erkrankt ist, was den Hauptgrund für die Vorstellung darstellte. Der Patient zeigte zudem Alarmsymptome wie einen Gewichtsverlust von 3 kg in 3 Monaten und zunehmende Schluckbeschwerden. Als Risikofaktoren bestanden langjähriger Nikotinabusus (30 Jahre, früher 20 Zigaretten täglich), regelmäßiger Alkoholkonsum und Übergewicht (95 kg bei 179 cm).

Patienteninformationen

- **Patient:** Oskar Schmidt (O-S-K-A-R S-C-H-M-I-D-T)
- **Alter:** 50 Jahre (geboren 17.09.1975)
- **Größe/Gewicht:** 179 cm, 95 kg (übergewichtig)
- **Beruf:** Schreiner (angestellt)
- **Familienstand:** Verheiratet, ein Sohn

Hauptbeschwerden

- **Retrosternale Schmerzen:** Im unteren Halsbereich bis zum Brustansatz, brennender Charakter
- **Schmerzintensität:** 5/10, im Verlauf zunehmend
- **Dysphagie:** Schluckbeschwerden, besonders bei fester Nahrung
- **Sodbrennen:** Häufiges, starkes Sodbrennen
- **Aufstoßen:** Regelmäßiges Aufstoßen
- **Völlegefühl:** Besonders beim späten Essen vor dem Schlafengehen
- **Triggerfaktoren:** Scharfes Essen, Schokolade, Kaffee (besonders heiß), heißes Essen generell, spätes Essen, Schnaps
- **Besserung:** Kurzzeitig durch kaltes Wasser
- **Nachtbeschwerden:** Nächtlicher Hustenreiz (trocken), häufiges Aufwachen, braucht 2 Kissen zum besseren Schlafen
- **Heiserkeit:** Morgens kratzig im Hals und heiser
- **Gewichtsverlust:** 3 kg in 3 Monaten aufgrund von Appetitlosigkeit und Beschwerden beim Essen

Vorgeschichte

Vorerkrankungen

- **Arterielle Hypertonie:** Noch nicht medikamentös behandelt, nur Lebensstilmodifikation empfohlen
- **Keine weiteren chronischen Erkrankungen**

Operationen

- Keine bisherigen Operationen

Medikation

- **Regelmäßig:** Keine Dauermedikation
- **Bei Bedarf:** Ibuprofen 500 mg gegen Kopfschmerzen
- **Vom Hausarzt verschrieben:** Pantoprazol (nicht mehr eingenommen, da keine Besserung)

Allergien

- Keine bekannten Allergien

Familienanamnese

WICHTIG: Bruder mit Speiseröhrenkrebs - Hauptgrund für die Vorstellung des Patienten, große Angst vor gleicher Erkrankung!

- **Vater:** Verstorben an arterieller Hypertonie
- **Mutter:** Verstorben (keine Details genannt)

Sozialanamnese und Noxen

- **Nikotin:** Raucher seit 30 Jahren, früher 20 Zigaretten/Tag, aktuell etwas reduziert (weniger als eine Packung/Tag)
- **Alkohol:** Regelmäßig eine Flasche Bier, manchmal Wein; früher auch Schnaps (aktuell vermieden wegen Beschwerden)
- **Drogen:** Früher ca. 2 Jahre lang gelegentlich Cannabis (Ausbildungszeit), aktuell nicht mehr
- **Sport:** Fahrradfahren (gelegentlich)
- **Reisen:** Letzter Auslandsaufenthalt vor 2 Jahren in Spanien

Verdachtsdiagnosen

- **Gastroösophagealer Reflux (GERD)** - Hauptverdacht

- **Ösophaguskarzinom** - Differentialdiagnostisch wichtig wegen:
 - Positive Familienanamnese (Bruder mit Speiseröhrenkrebs)
 - Alarmsymptome: Dysphagie, Gewichtsverlust (3 kg/3 Monate)
 - Risikofaktoren: Langjähriger Nikotinabusus, Alkoholkonsum
-

Diagnostisches Vorgehen

Körperliche Untersuchung

- Vitalparameter überwachen
- Besonderes Augenmerk auf Alarmsymptome (Dysphagie, Gewichtsverlust)
- Aktuelles Gewicht bestimmen

Laboruntersuchungen

- **Kleines Blutbild:** Anämiezeichen bei möglichem chronischem Blutverlust
- **Entzündungsparameter:** CRP, Leukozyten
- **Herzenzyme:** Zum Ausschluss kardialer Ursachen (Troponin)

Apparative Diagnostik

- **Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD):** Wichtigste diagnostische Maßnahme
 - **Biopsie:** Bei verdächtigen Befunden zur histologischen Sicherung
-

Therapieempfehlungen

Allgemeinmaßnahmen (ambulante Behandlung)

- **Nikotinkarenz** - wichtigste Maßnahme!
 - **Alkoholkarenz**
 - **Gewichtsreduktion** (Patient ist übergewichtig mit 95 kg bei 179 cm)
 - **Vermeidung von spätem Essen** vor dem Schlafengehen
 - **Vermeidung von Triggerfaktoren:** Scharfes Essen, Schokolade, Kaffee, heißes Essen
-

Feedback zur Prüfungsleistung

Stärken

- **Sehr gute sprachliche Sicherheit** im Deutschen

- **Vielfältige Frageformulierungen:** "Ist Ihnen aufgefallen", "Haben Sie bemerkt", "Sind Ihre Beschwerden schlimmer" - sehr variabel, nicht monoton
- **Patientenansprache mit Namen** durchgehend verwendet
- Strukturierte Anamnese mit allen relevanten Bereichen
- Gute Fallvorstellung mit Basisdaten

Verbesserungspotenzial

KRITISCHER PUNKT: Fehlende Erwähnung der Familienanamnese (Bruder mit Speiseröhrenkrebs) im Arzt-Arzt-Gespräch - dies ist ein wichtiger Grund für erhöhte Wachsamkeit und war der Hauptvorstellungsgrund des Patienten!

- Teilweise **bereits gegebene Informationen nochmals nachgefragt**, was beim Patienten zu unwirschem Reagieren führte
- **Impfstatus nicht abgefragt**
- **Voroperationen nicht erfragt**
- **Spezifische Triggerfaktoren** (Schokolade, Kaffee, scharfes Essen) nicht dezidiert im Arzt-Arzt-Gespräch erwähnt
- Falsche Schmerzausstrahlung angegeben: Patient sagte, Schmerzen strahlen **nicht** aus, wurde aber als ausstrahlend beschrieben
- Ungewöhnliche Formulierung: "herzliche Enzyme" statt "Herzenzyme"
- "Mediastinale Schmerzen" - besser wäre "retrosternale Schmerzen"

Prüfungsinformationen

- **Kandidat:** Fachrichtung Innere Medizin und Endokrinologie

Prüfungsprognose

Feedback der Simulationspatientin (Gerhild): "Sie müssen vor der Prüfung wirklich keine Angst haben. Eigentlich können die Ihnen so nichts wollen."

- Sprachliche Kompetenz sehr gut - nur wenige Fehler
- Strukturierte Anamneseführung
- Hauptverbesserungsbedarf: Vollständige Familienanamnese in der Fallvorstellung

Nächste Schritte

- Fortsetzung der Prüfungsvorbereitung am Dienstag
- Schwerpunkt: Vollständige Wiedergabe aller relevanten Informationen (insbesondere Familienanamnese) im Arzt-Arzt-Gespräch

Leistung des Kandidaten

Sprachliche Kompetenz

Der Kandidat zeigte eine **ausgezeichnete sprachliche Sicherheit** im Deutschen, obwohl er erst seit fast 3 Jahren in Deutschland lebt und die Sprache hier erlernt hat. Die Simulationspatientin betonte: "Sie müssen vor der Prüfung wirklich keine Angst haben. Eigentlich können die Ihnen so nichts wollen." Seine Sprachkenntnisse waren so gut, dass nur sehr wenige grammatikalische oder lexikalische Fehler auftraten.

Anamneseführung

Im Arzt-Patienten-Gespräch bewies der Kandidat eine **strukturierte und professionelle Gesprächsführung**. Besonders positiv hervorzuheben sind:

- **Vielfältige Frageformulierungen:** Der Kandidat verwendete abwechslungsreiche Formulierungen wie "Ist Ihnen aufgefallen", "Haben Sie bemerkt", "Sind Ihre Beschwerden schlimmer", was das Gespräch natürlich und nicht monoton wirken ließ
- **Patientenorientierte Kommunikation:** Er sprach den Patienten durchgehend mit Namen an, was eine persönliche und empathische Atmosphäre schuf
- **Systematische Anamnese:** Er erfragte methodisch alle relevanten Bereiche (Schmerzcharakteristik, vegetative Anamnese, Vorerkrankungen, Familienanamnese, Sozialanamnese, Noxen)
- **Differentialdiagnostisches Denken:** Er fragte gezielt nach Alarmsymptomen wie Schwarzstuhl, Bluthusten und Gewichtsverlust

Kritische Schwachpunkte

Trotz der insgesamt sehr guten Leistung gab es einige wichtige Verbesserungsbereiche:

- **KRITISCHSTER PUNKT - Fehlende Familienanamnese im Arzt-Arzt-Gespräch:** Der wichtigste Fehler war, dass der Kandidat die **Speiseröhrenkreberkrankung des Bruders** nicht in der Fallvorstellung erwähnte. Dies ist besonders gravierend, da es der Hauptvorstellungsgrund des Patienten war und ein entscheidendes differentialdiagnostisches Kriterium darstellt, das zu erhöhter Wachsamkeit bezüglich eines möglichen Ösophaguskarzinoms führen sollte
- **Redundante Nachfragen:** Teilweise wurden bereits vom Patienten gegebene Informationen nochmals nachgefragt, was zu unwirschem Reagieren führte. Dies deutet darauf hin, dass er nicht immer aufmerksam zuhörte oder die Informationen nicht sofort verarbeitete
- **Unvollständige Anamnese:** Impfstatus und Voroperationen wurden nicht systematisch abgefragt
- **Ungenauere medizinische Terminologie:**
 - "Mediastinale Schmerzen" statt korrekt "retrosternale Schmerzen"
 - "Herzliche Enzyme" (eine charmante aber falsche Formulierung) statt "Herzenzyme"
- **Fehlerhafte Schmerzlokalisierung:** Im Arzt-Arzt-Gespräch wurde angegeben, die Schmerzen würden ausstrahlen, obwohl der Patient explizit verneint hatte, dass sie ausstrahlen
- **Unvollständige Trigger-Nennung:** Die spezifischen Triggerfaktoren (Schokolade, Kaffee, scharfes Essen, heißes Essen) wurden nicht dezidiert im Arzt-Arzt-Gespräch erwähnt

Diagnostisches und therapeutisches Vorgehen

Der Kandidat entwickelte einen **angemessenen diagnostischen und therapeutischen Plan**:

- **Diagnostik:** Körperliche Untersuchung mit Vitalparametern, Gewichtskontrolle, Laboruntersuchungen (kleines Blutbild für Anämiezeichen, Entzündungsparameter, Herzenzyme zum kardialen Ausschluss) und als wichtigste Maßnahme eine Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) mit Biopsie bei verdächtigen Befunden
- **Therapie:** Er schlug eine ambulante Behandlung mit Allgemeinmaßnahmen vor: Nikotinkarenz (als wichtigste Maßnahme), Alkoholkarenz, Gewichtsreduktion und Vermeidung von spätem Essen vor dem Schlafengehen

Gesamtbewertung und Prognose

Der Kandidat zeigte eine **insgesamt sehr gute Prüfungsleistung** mit exzellenten Deutschkenntnissen und professioneller Gesprächsführung. Die Simulationspatientin gab eine **positive Prognose** ab und betonte, dass er keine Angst vor der Prüfung haben müsse. Der wichtigste Verbesserungsbedarf liegt in der **vollständigen und präzisen Wiedergabe aller relevanten Informationen**, insbesondere der Familienanamnese, im Arzt-Arzt-Gespräch. Mit fokussierter Übung auf diese Schwachpunkte sollte die FSP-Prüfung in Düsseldorf gut zu bewältigen sein.

Empfehlungen für die weitere Vorbereitung

- Schwerpunkt auf die **vollständige Fallvorstellung** legen, insbesondere auf die systematische Erwähnung der Familienanamnese
- **Aktives Zuhören** trainieren, um bereits gegebene Informationen nicht nochmals nachzufragen
- **Medizinische Terminologie** präzise verwenden (retrosternal statt mediastinal)
- **Vollständige Anamnese** auch unter Zeitdruck sicherstellen (Impfstatus, Voroperationen)
- Übung mit verschiedenen Fallszenarien zur Festigung der strukturierten Vorgehensweise